

藤田医科大学岡崎医療センター 抗菌薬適正使用支援チーム
経口抗菌薬の腎機能別投与量ガイドンス（2025. 6. 26）

β-ラクタム系抗菌薬

1. [アモキシシリン](#) [Access](#)
2. [アモキシシリン/クラバン酸](#) [Access](#) ※[スルタミシリン](#) [Access](#)
3. [セファレキシン](#) [Access](#)
4. [セファクロル](#) [Watch](#)
5. [第3世代経口セファロスポリン系抗菌薬](#) [Watch](#)

マクロライド系抗菌薬

6. [アジスロマイシン](#) [Watch](#)
7. [クラリスロマイシン](#) [Watch](#)

フルオロキノロン系抗菌薬

8. [レボフロキサシン](#) [Watch](#)
9. [その他のフルオロキノロン系抗菌薬](#) [Watch](#)

その他

10. [ドキシサイクリン/ミノサイクリン](#) [Access](#)/[Watch](#)
11. [ST 合剤](#) [Access](#)
12. [クリンダマイシン](#) [Access](#)
13. [メトロニダゾール](#) [Access](#) ※[ホスホマイシン](#) [Watch](#)

抗真菌薬

14. [テルビナフィン](#)
15. [フルコナゾール](#)

抗ウイルス薬

16. [オセルタミビル](#)
17. [ザナミビル・ラニナミビル](#)
18. [バラシクロビル](#)
19. [モルヌピラビル](#)
20. [ニルマトレルビル/リトナビル](#) ※[エンシトレルビル](#)

その他

21. [アトバコン](#)

AWaRe 分類とは

・ 抗菌薬の適正使用を推進し、薬剤耐性の拡大を抑制することを目的とした、世界保健機関（WHO）による抗菌薬分類システムで、抗菌薬を Access, Watch, Reserve の 3 つに分類する。

Access 抗菌薬：一般的な感染症に対して、第一または第二選択として使用される抗菌薬。安全で、効果が高く、低コスト。他の選択肢があるため、耐性化した際の不利益が小さい。

Watch 抗菌薬：耐性化した際に他の選択肢が少ないため、限られた疾患や適応にのみ使用が求められる抗菌薬で、不適切な使用が临床上重要な薬剤耐性菌の急速な拡大につながる可能性がある。

Reserve 抗菌薬：耐性化した際に取り得る他の選択肢が非常に少ないため、他の手段が使えなくなった場合の最後の手段として使用すべき抗菌薬。多剤耐性菌による感染症が疑われる、あるいは確認された場合に限り使用すべき抗菌薬。

・ この分類は、抗菌薬がどの程度、どのように使用されているかを把握し、使用の最適化に向けた具体的な目標を設定するとともに、実際の使用状況をモニタリングすることにより、抗菌薬適正使用（Antimicrobial Stewardship：AS）活動の効果を評価するための有用なツールとして位置づけられている。

・ 特に、抗菌薬の不適切な使用や過剰使用を防ぎ、耐性菌の出現および拡散を抑制することが期待されており、薬剤耐性の影響を考慮した上で、臨床現場および公衆衛生政策における抗菌薬使用の最適化を目指す取り組みの一環として活用されている。

・ WHO は、抗菌薬全体の使用に占める Access 抗菌薬の割合を 60%以上にすることを目標として掲げている。ただし、これは各施設での目標値ではなく、地域全体や国全体といった集団レベルにおける抗菌薬使用に関する指標である。例えば、結核病院や呼吸器専門病院など、特定の診療領域を扱う施設においては、マクロライド系抗菌薬やリファンピシンの使用割合が高くなるのは合理的な臨床判断であり、Access 抗菌薬の使用比率が低いことが、直ちに不適切な抗菌薬使用を意味するものではない。

・ AWaRe 分類は本来、政策評価や大規模な使用傾向の把握を目的としたツールであるが、2024 年度から抗菌薬適正使用体制加算（5 点：入院患者 1 名につき 1 回算定できる）が新設され、施設単位で Access 抗菌薬使用率の向上が推奨されるようになった。この加算の取得要件には、Access 抗菌薬の使用率が数値化可能なサーベイランス（J-SIPHE）に参加していること、直近 6 カ月に使用した外来処方の抗菌薬のうち、Access 抗菌薬の使用率が 60%以上、または、登録施設のうち上位 30%以内であること、が含まれる

1. アモキシシリン（商品名：アモキシシリン、サワシリン）

Access

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：1 回 500mg 1 日 3 回
- ・ 日本の添付文書の最大投与量：1 日 1000mg を適宜増減

・ 投与量

CrCl	投与量・投与方法
30～	1 回 500mg 1 日 3 回
～30	1 回 500mg 1 日 2 回
血液透析	1 回 500mg 1 日 2 回
腹膜透析	1 回 500mg 1 日 2 回

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ アモキシシリン®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版

2. アモキシシリン/クラブラン酸（商品名：オーグメンチン配合錠 250RS）

[Access](#)

- ・日本で販売されているオーグメンチン配合錠はアモキシシリン成分が少ない
→オーグメンチン1錠は、アモキシシリン1錠剤と一緒に内服することを基本とする
→AMMPC 250mg/CVA 125mg + AMPC 250mg で、1回 AMPC 500mg/CVA 125mg となる
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日4錠を適宜増減

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
30～	1回 500/125mg 1日3回
10～30	1回 500/125mg 1日2回
～10	1回 500/125mg 1日1回
血液透析	1回 500/125mg 1日1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 500/125mg 1日2回

※参考：スルタミシリン（ユナシン錠 375mg®）

[Access](#)

- －使用方法：1回1錠 1日3回で使用
- －腸管で吸収された後、腸管のエステラーゼにより加水分解されて、ABPC/SBT となる
- －投与量調整：CCr<30（透析を含む）の場合に1日2回へ減量検討する

参考

- ・UpToDate 2025
- ・オーグメンチン®・ユナシン錠 375mg®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

3. セファレキシン（商品名：セファレキシン、ケフレックス、ラリキシン）

Access

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 500mg 1日 4回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 2000mg まで

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
30～	1回 500mg 1日 4回
15～30	1回 500mg 1日 3回
～15	1回 500mg 1日 2回
血液透析	1回 500mg 1日 2回
腹膜透析	1回 500mg 1日 2回

・膀胱炎または咽頭炎の場合

CrCl	投与量・投与方法
30～	1回 500g 1日 2回
15～30	1日 500mg 1日 1回
～15	1回 250mg 1日 1回
血液透析	1回 250mg 1日 1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 250mg 1日 1回

参考

- ・UpToDate 2025
- ・セファレキシン®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

4. セファクロル（商品名：セファクロル、ケフラール） [Watch](#)

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：1 回 500mg 1 日 3 回
- ・ 日本の添付文書の最大投与量：1 日 1500mg まで

・ 投与量

CrCl	投与量・投与方法
10～	1 回 500mg 1 日 3 回
～10	1 回 500mg 1 日 2 回
血液透析	1 回 500mg 1 日 2 回
腹膜透析	1 回 500mg 1 日 2 回

・ 使用時の注意点

- 他の経口 β ラクタム系抗菌薬と比較して血清病のリスクが 15 倍と報告されている
- セファレキシンの代替薬である（セファレキシンを優先して使用する）

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ ケフラール®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版

5. 第3世代経口セファロスポリン系抗菌薬 Watch

・セフジニル（商品名：セフゾン、セフジニル）

- 日本の添付文書の最大投与量：1日300mg（1回100mg 1日3回）まで
- 経口吸収率 約20%、半減期 1.7時間

CrCl	投与量・投与方法
30～	1回100mg 1日3回 ※海外では1回300mg 1日2回
～30	1回100mg 1日3回 ※海外では1回300mg 1日1回
血液透析	1回100mg 1日1回 ※海外では1回300mg 1日1回
腹膜透析	データなし

・セフジトレン・ピボキシル（商品名：メイアクト、セフジトレン）

- 日本の添付文書の最大投与量：1日600mg（1回200mg 1日3回）まで
- 経口吸収率 16%、半減期 1.6時間

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回200mg 1日3回 ※海外では1回400mg 1日2回
10～50	1回200mg 1日2回
～10	1回200mg 1日1回
血液透析	1回200mg 1日1回
腹膜透析	1回200mg 1日1回

参考

- ・UpToDate 2025
- ・セフゾン®・メイアクト®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版

6. アジスロマイシン（商品名：アジスロマイシン、ジスロマック） Watch

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：1 回 500mg 1 日 1 回
- ・ 日本の添付文書の最大投与量：1 日 500mg まで
- － クラミジア子宮頸管炎・尿道炎の場合は、1000mg 単回投与を行う

・ 投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	1 回 500mg 1 日 1 回 3 日間 ※レジオネラ肺炎などでは、適宜投与期間を延長する ※クラミジア尿道炎/子宮頸管炎：1000mg 単回投与 ※肺非結核性抗酸菌症：1 回 250mg 1 日 1 回 長期間投与

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ ジスロマック®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・ 日本結核・非結核性抗酸菌症学会. 成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解 -2023 年改訂-
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

7. クラリスロマイシン（商品名：クラリスロマイシン、クラリス、クラリシッド） [Watch](#)

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：1 回 500mg 1 日 2 回（海外）
- ・ 日本の添付文書の最大投与量：1 回 200mg 1 日 2 回まで（NTM 症では 1 回 400mg 1 日 2 回まで可）
- ・ 本邦では標準投与量が使用できないため、原則としてアジスロマイシンを使用する
 - － クラリスロマイシンを使用する場合は、腎機能に関係なく、1 回 200mg 1 日 2 回でよい

・ 投与量

CrCl	投与量・投与方法
30～	1 回 200mg 1 日 2 回 ※海外では 1 回 500mg 1 日 2 回
～30	1 回 200mg 1 日 1～2 回 ※海外では 1 回 500mg 1 日 1 回
血液透析	1 回 200mg 1 日 1～2 回 ※海外では 1 回 500mg 1 日 1 回
腹膜透析	1 回 200mg 1 日 1～2 回 ※海外では 1 回 500mg 1 日 1 回

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ クラリスロマイシン®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版

8. レボフロキサシン（商品名：レボフロキサシン、クラビット） Watch

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：1 回 500mg 1 日 1 回
- ・ 日本の添付文書の最大投与量：1 日 500mg まで

・ 投与量（腎機能に関係なく初回は 500mg 投与する）

CrCl	投与量・投与方法
50～	1 回 500mg 1 日 1 回
20～50	1 回 250mg 1 日 1 回
～20	1 回 250mg 2 日 1 回
血液透析	1 回 250mg 2 日 1 回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1 回 250mg 2 日 1 回

・ フルオロキノロン系抗菌薬の使用時の注意点

- － 内服薬は、多価陽イオン製剤（Al, Fe, Ca, Mg, Zn）と同時投与すると吸収が低下する
 1. 併用を避ける
 2. レボフロキサシンの内服前後 2～4 時間の多価陽イオン製剤の内服を避ける

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ レボフロキサシン®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

9. その他のフルオロキノロン系抗菌薬

・ガレノキサシン（ジェニナック®） **Watch**

- 正常腎機能の場合の推奨量：1回 400mg 1日1回

CrCl	投与量・投与方法
30～	1回 400mg 1日1回
～30	1回 200mg 1日1回
血液透析・腹膜透析	データなし

・シタフロキサシン（グレースビット®） **Watch**

- 正常腎機能の場合の推奨量：1回 50～100mg 1日2回

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 50～100mg 1日2回
30～50	1回 50～100mg 1日1回
10～30	1回 50～100mg 2日1回
血液透析・腹膜透析	データなし

・ラスクフロキサシン（ラスビック®） **Watch**

- 正常腎機能の場合の推奨量：1回 75mg 1日1回
- 腎機能による投与量調整不要

・フルオロキノロン系抗菌薬の使用時の注意点

- 内服薬は、多価陽イオン製剤（Al, Fe, Ca, Mg, Zn）と同時投与すると吸収が低下する
 1. 併用を避ける
 2. フルオロキノロン系抗菌薬内服前後 2～4 時間の多価陽イオン製剤の内服を避ける

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ ジェニナック®・グレースビット®・ラスビック®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

10. ドキシサイクリン（商品名：ビブラマイシン） Access

ミノサイクリン（商品名：ミノサイクリン、ミノマイシン） Watch

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：1 回 100mg 1 日 2 回
- ・ 日本の添付文書の最大投与量：
ドキシサイクリン 初日 200mg、2 日目から 100mg を基本として適宜増減
ミノサイクリン 1 日 200mg まで

・ 投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	1 回 100mg 1 日 2 回

・ 使用時の注意点

- 多価陽イオン製剤（Al, Fe, Ca, Mg, Zn）と同時投与すると吸収が低下する
 1. 多価陽イオン製剤の併用を避ける
 2. ドキシサイクリン・ミノサイクリン内服の前後 4 時間の多価陽イオン製剤内服を避ける
- ミノサイクリン内服中は、めまいが出現することがあるため、自動車の運転等危険を伴う機械の操作及び高所での作業等に従事させないように指導する
- 食道潰瘍のリスクを減らすために、多めの水で服用し、その後少なくとも 30 分間坐位を保つように指導する

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ ビブラマイシン®・ミノサイクリン®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

11. ST 合剤（スルファメトキサゾール・トリメトプリム）（商品名：バクタ、ダイフェン）

Access

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：疾患によって異なる（下記参照）
 - ・ 日本の添付文書の最大投与量：トリメトプリムとして 20mg/kg/日
- ※1錠に、SMX 400mg、TMP 80mg が含まれている

・ 疾患別の標準的な投与量

疾患	投与量
尿路感染症 皮膚軟部組織感染症 腹腔内感染症	1回2錠 1日2回 S. aureus の場合、1回3～4錠 1日2回への増量を検討
骨・関節感染症	1回3～4錠 1日2回
PCP（HIV/非 HIV 感染者） Listeria 感染症 Nocardia 脳膿瘍 中枢神経感染症	トリメトプリム量で 15 mg/kg/日 分3～4 ※非 HIV 感染者の PCP は、10 mg/kg/日まで減量検討可

PCP：ニューモシスチス肺炎

・ 投与量調整

CrCl	投与量、投与方法
30～	100%
15～30	50%に減量、2回に分けて投与
～15	25～33%に減量、1日1回投与
血液透析	25～33%に減量、1日1回投与 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	25～33%に減量、1日1回投与

・ 使用時の注意点

- － 禁忌：サルファ剤アレルギー、妊娠または妊娠している可能性のある女性（投与後1か月避妊）
- － 高用量の使用によって、副作用が高頻度で出現する
- － 注意すべき副作用は、食欲低下、薬疹、薬剤熱、骨髄抑制、低 Na 血症、高 K 血症、腎障害など

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ ダイフェン®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版.
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

12. クリンダマイシン（商品名：ダラシン） [Access](#)

- ・正常腎機能の場合の推奨量（海外）：1回 450～600mg 1日3回（内服）
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 900mg まで

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	咽頭炎：1回 300mg 1日3回 咽頭炎以外：1回 450mg 1日3回

参考

- ・UpToDate 2025
- ・ダラシン®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

13. メトロニダゾール（商品名：フラジール） Access

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 500mg 1日 2～3回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 2000mg まで

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	嫌気性菌感染症・膣トリコモナス症：1回 500mg 1日 2回 中枢神経感染症・CDI・アメーバ赤痢：1回 500mg 1日 3回 破傷風：1回 500mg 1日 4回
～10	1回 500mg 1日 2回（疾患は関係ない）
血液透析	投与量調整不要
腹膜透析	投与量調整不要

参考

- ・UpToDate 2025.

腎機能低下はメトロニダゾール本体の血中半減期に影響しないが、活性代謝物やほぼ不活性な酢酸代謝物が蓄積し、神経障害・脳症・痙攣などの中枢神経系副作用のリスクが高まる。メトロニダゾールおよび代謝物は42～65%が透析で除去される。

- ・フラジール®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)
- ・Br Med J (Clin Res Ed). 1985;291(6496):648-650.
- ・Int J Antimicrob Agents. 2025;65(3):107403.

※ホスホマイシン（商品名：ホスミシン、ホスホマイシン） Watch

- ・日本のホスホマイシンはカルシウム塩製剤で、海外はトロメタミン塩製剤のため同等ではない
- ・日本のホスホマイシンはbioavailabilityが悪いと報告されている
- ・使用方法：2～3gを分3または分4で使用する
- ・腎不全患者のデータは少ないが、短期使用であれば投与量の調節は不要である

14. テルビナフィン（商品名：テルビナフィン、ラミシール）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 125mg 1日1回（海外では1回 250mg 1日1回）
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 125mg まで
- ・爪白癬などで使用する

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 125mg 1日1回 ※海外では1回 250mg 1日1回
20～50	1回 125mg 1日1回 ※データは限定的である
～20	データなし（他剤を推奨する）
血液透析	データなし（他剤を推奨する）
腹膜透析	データなし（他剤を推奨する）

・使用時の注意点

- － 薬剤性肝障害に注意する（治療開始2か月以内は、月1回は血液検査を行う）
- － Cr 50未満の場合は、血液検査の頻度を増やすことを検討する

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ ラミシール®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

15. フルコナゾール（商品名：フルコナゾール、ジフルカン）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 400mg 1日1回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 400mg まで

- ・投与量（腎機能に関係なく、初回は通常量を投与する）

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 100～400mg 1日1回 ※基本は1回 400mg ※食道カンジダ症は1回 200mg、口腔カンジダは 100mg
～50	1回 50～200mg 1日1回（正常腎機能時の 50%量）
血液透析	1回 100～400mg 週3回透析後投与
腹膜透析	1回 50～200mg 1日1回（正常腎機能時の 50%量）

参考

- ・UpToDate 2025
- ・ジフルカン®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

16. オセルタミビル（商品名：オセルタミビル、タミフル）

・正常腎機能の場合の推奨量：

治療：1回 75mg 1日2回 5日間

予防：1回 75mg 1日1回 7～10日間

・75mg より少ない1回投与量の場合（30mg/回）は、ドライシロップ製剤を使用する

・投与量（治療/予防）

CrCl	投与量・投与方法
30～	1回 75mg 1日2回 / 1回 75mg 1日1回 ※海外では、30～60 の場合、1回 30mg 1日2回 / 1回 30mg 1日1回
10～30	1回 75mg 1日1回 / 1回 75mg 2日1回 ※海外では、1回 30mg 1日1回 / 1回 30mg 2日1回
～10	1回 30mg 2日1回 / 1回 30mg 週1回 （確立した投与量はない）
血液透析	1回 30mg（初回投与し、その後は透析後投与） / 1回 30mg（初回投与し、その後は透析2回に1回透析後に投与する）
腹膜透析	1回 75mg 投与 / 1回 30mg 投与（必要時、週に1回 30mg 投与する）

参考

・ UpToDate 2025

・ オセルタミビル®の添付文書

・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版

・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン

(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

17. ザナミビル（商品名：リレンザ）・ラニナミビル（商品名：イナビル）

- ・吸入薬であり、腎機能による投与量調整は不要である

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ リレンザ®・イナビル®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

18. バラシクロビル（商品名：バルトレックス、バラシクロビル）

・正常腎機能の場合の推奨量：

単純疱疹（HSV）：1回 500mg 1日2回

水痘または帯状疱疹（VZV）：1回 1000mg 1日3回

・投与量（HSV/VZV）

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 500mg 1日2回 / 1回 1000mg 1日3回
30～50	1回 500mg 1日2回 / 1回 1000mg 1日2回
10～30	1回 500mg 1日1回 / 1回 1000mg 1日1回
～10	1回 500mg 1日1回
血液透析	1回 500mg 1日1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 500mg 1日1回

参考

・UpToDate 2025

・バルトレックス®の添付文書

・サンフォード感染症治療ガイド Update 版

・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン

(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

19. モルヌピラビル（商品名：ラゲブリオ）

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：1 回 800mg 1 日 2 回、5 日間

・ 投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	1 回 800mg 1 日 2 回

・ 使用時の注意点

- － 呼吸不全のない軽症または中等症 I の COVID-19 患者が対象となる
- － 発症 5 日以内に開始する必要がある
- － 妊婦または妊娠している可能性のある女性（胎児毒性）、18 歳未満（骨・軟骨毒性）には禁忌である
- － 使用中と最終投与後 4 日間は避妊を行うように指導する

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ ラゲブリオ®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

20. ニルマトレルビル/リトナビル（商品名：パキロビッド）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 300mg/100mg 1日2回、5日間

・投与量

eGFR (mL/min) ※	投与量・投与方法
60～	1回 300mg/100mg 1日2回
30～60	1回 150mg/100mg 1日2回
～30	使用不可
血液透析	使用不可
腹膜透析	使用不可

※ クレアチニンクリアランス（CrCl）ではないことに注意する

・使用時の注意点

- －呼吸不全のない軽症または中等症ⅠのCOVID-19患者が対象となる
- －発症5日以内に開始する必要がある
- －薬物相互作用に注意する（併用注意薬と併用禁忌薬が多いため、添付文書等を参照する）

参考

- ・UpToDate 2025
- ・パキロビッド®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

※エンシトレルビル（商品名：ゾコーバ）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1日目：1回 375mg 1日1回、2-5日目：1回 125mg 1日1回
- ・腎機能による投与量調整は不要である
- ・使用時の注意点
 - －呼吸不全のない軽症または中等症ⅠのCOVID-19患者が対象となる
 - －発症72時間以内に開始する必要がある
 - －薬物相互作用に注意する（併用注意薬と併用禁忌薬が多いため、添付文書等を参照する）
 - －禁忌：妊娠、または、妊娠している可能性のある女性、12歳未満

参考

- ・ゾコーバ®の添付文書

21. アトバコン（商品名：サムチレール）

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：

治療：1 回 750mg 1 日 2 回、予防：1 回 1500mg 1 日 1 回

- ・ 適応：ニューモシスチス肺炎の治療、および、予防

- ・ 投与量（治療/予防）

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	1 回 750mg 1 日 2 回 / 1 回 1500mg 1 日 1 回

- ・ 使用時の注意点

- 絶食下では吸収が低下するため、食後（特に高脂肪食摂取後）に内服することが推奨されている

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ サムチレール®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)